

1. Introducción y relevancia clínica

La ictericia neonatal corresponde a la coloración amarillenta de piel y mucosas causada por acumulación de bilirrubina sérica, visible clínicamente cuando supera los 5 mg/dL.

Aproximadamente el 60 % de los recién nacidos de término y el 80 % de los prematuros desarrollan algún grado de ictericia durante la primera semana de vida. En la mayoría, es un fenómeno fisiológico y transitorio, pero en algunos casos puede indicar una enfermedad subyacente grave o alcanzar niveles neurotóxicos.

La diferenciación entre ictericia fisiológica y patológica es clave para prevenir la encefalopatía bilirrubínica (kernicterus), una complicación irreversible.

En el EUNACOM, este tema aparece con frecuencia en casos de recién nacidos en control o en hospitalización, donde se debe decidir si la ictericia es normal, requiere estudio o manejo con fototerapia o exanguinotransfusión.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Metabolismo normal de la bilirrubina

1. Producción:

- La bilirrubina proviene del catabolismo del grupo hemo (principalmente de la hemoglobina fetal).
- El RN produce aproximadamente 6–8 mg/kg/día, el doble que un adulto.

2. Transporte:

- La bilirrubina no conjugada (indirecta) se une a albúmina plasmática y se transporta al hígado.

3. Conjugación hepática:

- En el hepatocito, la uridilglucuroniltransferasa (UGT1A1) transforma la bilirrubina indirecta en conjugada (directa), hidrosoluble y excretable.

4. Excreción intestinal:

- En el intestino, la bilirrubina conjugada se transforma en urobilinógeno y estercobilina, que se eliminan en heces.
- Parte se reabsorbe por circulación enterohepática.

b. Causas de hiperbilirrubinemia neonatal

Mecanismo	Ejemplo clínico
↑ Producción de bilirrubina	Hemólisis (incompatibilidad Rh o ABO), hematomas, policitemia
↓ Captación o conjugación hepática	Prematurez, hipotiroidismo, síndrome de Crigler-Najjar o Gilbert
↑ Circulación enterohepática	Lactancia materna exclusiva, íleo, falta de alimentación

c. Factores predisponentes

- Prematurez.
- Lactancia exclusiva con ingesta inadecuada.
- Asfixia o hipoxia.
- Acidosis.
- Hipoalbuminemia.
- Poliglobulia o hematoma cefálico.
- Incompatibilidad Rh o ABO.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Ictericia fisiológica

Características típicas:

- Aparece después de las 24 horas de vida.
- Pico máximo:
 - 3°–5° día en RN de término.
 - 5°–7° día en prematuros.
- Descenso progresivo a partir del 7°–10° día.
- Bilirrubina total ≤ 12 mg/dL en RN de término (≤ 15 mg/dL en prematuros).
- Sin compromiso general ni coluria/acolia.

Mecanismos:

- Mayor producción de bilirrubina (turnover eritrocitario).
- Actividad enzimática hepática baja (UGT1A1 inmadura).
- Aumento de circulación enterohepática.

b. Ictericia patológica

Características de alarma:

- Inicio antes de las 24 horas.
- Bilirrubina > 12 mg/dL en término o > 15 mg/dL en pretérmino.
- Aumento > 5 mg/dL en 24 h.
- Presencia de coluria o acolia (bilirrubina conjugada).
- Duración > 2 semanas (o > 3 en prematuros).

- Síntomas acompañantes: letargia, rechazo alimentario, hipotonía, fiebre o convulsiones.
-

c. Ictericia por lactancia materna

1. Ictericia por falta de ingesta:

- Primeros 2–4 días de vida, asociada a escaso aporte de leche.
- Mecanismo: deshidratación y aumento de circulación enterohepática.
- Manejo: mejorar técnica e incrementar lactancia.

2. Ictericia por leche materna (verdadera):

- Aparece al 5°–7° día, puede durar varias semanas.
 - Bilirrubina total ≤ 15 mg/dL, RN en buen estado general.
 - No requiere suspender lactancia.
-

d. Ictericia conjugada (colestásica)

- Bilirrubina directa >2 mg/dL o >20 % del total.
 - Siempre patológica.
 - Causas: atresia biliar, hepatitis neonatal, infección urinaria, hipotiroidismo, errores metabólicos.
 - Requiere estudio urgente.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Medición de bilirrubina

- **Bilirrubina total y directa:** diferenciación entre fracción conjugada y no conjugada.
- **Bilirrubina transcutánea:** útil para tamizaje, requiere confirmación sérica si valores elevados.
- **Gráfica de Bhutani (AAP 2022):**
 - Permite interpretar el valor según edad posnatal (en horas).
 - Define zonas de bajo, intermedio o alto riesgo de hiperbilirrubinemia severa.

b. Otros exámenes según sospecha

Sospecha	Exámenes recomendados
Hemólisis	Hemograma, reticulocitos, grupo y Rh madre/hijo, test de Coombs directo
Infección	Hemocultivo, PCR, uroanálisis
Disfunción hepática	TGO/TGP, FA, GGT, ecografía hepática
Enfermedad metabólica	TSH, galactosa, aminoacidograma

5. Tratamiento (según guías MINSAL / AAP 2022)

a. Medidas generales

- **Asegurar alimentación frecuente y efectiva** (8–12 tomas/día).
- **Mantener temperatura corporal adecuada.**

- Evitar ayuno o deshidratación.
 - Control clínico y de bilirrubina según edad y factores de riesgo.
-

b. Fototerapia

Indicaciones:

- Bilirrubina en zona de riesgo intermedio o alto según nomograma.
- Aumento $>0,5$ mg/dL/h o >5 mg/dL/día.
- Presencia de factores de riesgo: prematurez, hemólisis, asfixia.

Mecanismo:

Convierte la bilirrubina no conjugada en fotoisómeros solubles excretables sin conjugación hepática.

Parámetros técnicos:

- Luz azul (460–490 nm).
 - Distancia 30–40 cm.
 - Ojos protegidos; mantención de hidratación.
 - Reevaluar bilirrubina cada 12–24 h.
-

c. Exanguinotransfusión

Indicaciones (AAP/MINSAL):

- Bilirrubina total >25 mg/dL (término).
- Bilirrubina >20 mg/dL + hemólisis o síntomas neurológicos.
- Falta de respuesta a fototerapia intensiva.

Objetivo: remover bilirrubina y anticuerpos hemolíticos.

d. Tratamiento específico según etiología

Etiología	Tratamiento
Incompatibilidad Rh o ABO	Inmunoglobulina EV (500–1000 mg/kg) + fototerapia
Ictericia por lactancia	Aumentar frecuencia de tomas, NO suspender lactancia
Ictericia colestásica	Derivar a gastroenterología pediátrica
Infección o hipotiroidismo	Tratamiento etiológico específico

6. Complicaciones y pronóstico

a. Encefalopatía bilirrubínica (kernicterus)

Mecanismo:

Depósito de bilirrubina no conjugada en núcleos de la base (ganglios basales, tálamo, hipocampo).

Síntomas:

- **Letargia, hipotonía, succión débil → rigidez, convulsiones, fiebre.**
- **Secuelas: sordera neurosensorial, parálisis cerebral, retraso cognitivo.**

Riesgo aumentado si:

- **Prematurez.**
- **Hipoalbuminemia.**

- Asfixia o acidosis.
 - Fármacos que desplazan bilirrubina (sulfas, ceftriaxona).
-

b. Pronóstico

- Ictericia fisiológica: excelente, autolimitada.
 - Ictericia patológica tratada precozmente: evolución favorable.
 - Ictericia no tratada: riesgo permanente de daño neurológico.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. Toda ictericia antes de las 24 h es patológica.
2. Bilirrubina directa elevada = colestasis.
3. Fototerapia es el tratamiento de elección para la hiperbilirrubinemia indirecta.
4. No se suspende la lactancia materna por ictericia.
5. La encefalopatía bilirrubínica es prevenible con pesquisa y fototerapia oportuna.
6. En RN pretérmino, los umbrales de fototerapia son más bajos.
7. Acolia y coluria orientan a ictericia conjugada → estudio hepático urgente.

□ Errores frecuentes:

- No medir bilirrubina por creer que es “fisiológica”.
- Indicar agua o glucosa en lugar de aumentar lactancia.
- Usar antibióticos sin indicación.

- No diferenciar entre fracción directa e indirecta.
 - Suspender innecesariamente la lactancia.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La ictericia neonatal es común y generalmente fisiológica, pero puede ser signo de patología grave.
2. Inicio antes de 24 h, bilirrubina alta o colestasis → estudio urgente.
3. Bilirrubina indirecta elevada = fisiológica o por lactancia; directa elevada = colestásica.
4. Fototerapia es el tratamiento base y segura.
5. Exanguinotransfusión se reserva para hiperbilirrubinemia severa o hemólisis.
6. No suspender lactancia materna.
7. Prevención del kernicterus depende del diagnóstico precoz y manejo oportuno.